

**PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN KESEHATAN
PT ASURANSI JIWA TEGUH PELITA PELINDUNG
DENGAN**

PT DISA PRIMA MEDIKA [mohon isi nama badan hukum]

Nomor : [mohon isi]

Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada 1 Januari 2025 [mohon isi], oleh dan antara:

1. **PT ASURANSI JIWA TEGUH PELITA PELINDUNG**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di DKI Jakarta, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 18, Jl. M. H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh [UNTUK DIISI KEMUDIAN], bertindak dalam kedudukannya selaku **Direktur PT Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung**, dari dan oleh karenanya sah, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung**, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “Pihak Pertama”; dan

Formatted: Indent: Hanging: 0,63 cm, Tab stops: Not at 1,27 cm

2. **PT DISA PRIMA MEDIKA** [mohon isi nama badan hukum], suatu badan usaha [mohon isi jenis badan hukum] yang didirikan berdasarkan Akta nomor 26 tanggal 28 bulan November 2009, dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H, Notaris di Kota Malang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01 tahun 2009 berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malang [mohon isi kota], beralamat di Banjararum Selatan No.3 Kecamatan Singosari, kabupaten Malang, Jawa Tiimur [mohon isi alamat lengkap badan hukum], dalam hal ini diwakili oleh **Endang Susilowati** [mohon isi], bertindak dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** [mohon isi], dari dan oleh karenanya sah, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama [mohon isi nama badan hukum] **PT DISA PRIMA MEDIKA** selaku badan usaha pengelola rumah sakit :

Formatted: Indent: First line: 0 cm

A. Rumah Sakit Prima Husada Malang dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Indent: Left: 0,75 cm, No bullets or numbering

B. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang beralamat di Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Formatted: Indent: Left: 2,02 cm, No bullets or numbering

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: A, B, C, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,39 cm + Indent at: 2,02 cm

Formatted: Font: (Default) + Body (Calibri), 11 pt

2. Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai “Pihak Kedua”.

Formatted: Indent: Left: 0,75 cm, No bullets or numbering

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**Pihak**”.

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha asuransi yang menyediakan penjaminan bagi Peserta (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
2. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu badan usaha pengelola rumah sakit mohon isi jenis badan hukum yang bergerak pada bidang usaha aktivitas kesehatan manusia yang melaksanakan kegiatan usaha rumah sakit/ klinik utama rumah sakit dengan keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai “**Faskes**”).
3. Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama di mana Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan Pelayanan Kesehatan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada Peserta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 – DEFINISI

1. “**Pelayanan Kesehatan**” adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Peserta dalam ruang lingkup Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
2. “**Pelayanan Gawat Darurat**” adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan untuk Peserta yang berada pada keadaan klinis yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan disabilitas.
3. “**Pelayanan Rawat Inap**” adalah Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur/menginap di Faskes.
4. “**Pelayanan Rawat Jalan**” adalah Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal/menginap di ruang rawat inap di Faskes.
5. “**Medical Check Up**” adalah pemeriksaan medis terhadap Peserta untuk mengetahui secara dini tentang keadaan/kondisi kesehatan Peserta tersebut.
6. “**Peserta**” adalah orang-orang yang menjadi tanggungan Pihak Pertama yang dibuktikan dengan Kartu Peserta.
7. “**Kartu Peserta**” adalah kartu fisik maupun digital yang diterbitkan oleh Pihak Pertama yang merupakan bukti kepesertaan Peserta sebagai tertanggung Pihak Pertama, dalam bentuk yang secara substansial sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian ini dan/atau akan diberitahukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
8. “**Faskes Rekanan**” adalah fasilitas kesehatan lain yang bekerja sama dengan Pihak Pertama dan merupakan rekanan Pihak Pertama, di mana apabila Pihak Kedua tidak dapat memberikan Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan oleh Peserta, maka Faskes dapat merujuk Peserta ke Faskes Rekanan yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan dengan persetujuan Pihak Pertama.
9. “**Surat Rujukan**” adalah surat resmi yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk Peserta ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat selanjutnya, dalam hal diperlukan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

penanganan medis lebih lanjut atau Pelayanan Kesehatan spesialis tertentu yang tidak dapat ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk tersebut.

10. **"Formulir Rawat Jalan"** adalah surat dengan dalam bentuk yang secara substansial terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian ini, yang diisi dan ditandatangani oleh dokter penanggung jawab atas Peserta dan Peserta, dan dikirimkan kepada Pihak Pertama sebagai syarat penagihan kepada Pihak Pertama, dalam bentuk yang secara substansial terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
11. **"Struk Discharge Rawat Jalan"** atau **"Struk Discharge"** adalah surat yang diterbitkan oleh Pihak Pertama secara elektronik, yang merupakan hasil dari sejumlah informasi yang dimasukkan secara mandiri oleh Pihak Kedua ke dalam Web Portal setelah Peserta memperoleh Pelayanan Rawat Jalan dan sebelum Peserta meninggalkan Faskes, dan menerangkan nilai biaya Pelayanan Kesehatan yang dijamin, tidak dijamin, serta ketentuan umum penjaminan Peserta, dalam bentuk yang secara substansial terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
12. **"Surat Persetujuan Pemberian Pelayanan"** atau **"Surat Jaminan Awal"** adalah surat yang diterbitkan oleh Pihak Pertama secara elektronik, di mana berdasarkan informasi medis dan/atau Formulir LMA yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama menjamin biaya Pelayanan Kesehatan selama Peserta mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Faskes, dalam bentuk yang secara substansial terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
13. **"Formulir LMA"** adalah Formulir Lembar Medis Awal yang merupakan surat permintaan keterangan mengenai kondisi Peserta dari dokter yang merawat pada saat Peserta pertama kali mendapatkan pemeriksaan ke Fasilitas Kesehatan, dengan bentuk yang secara substansial sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
14. **"Surat Persetujuan Pembayaran"** atau **"Surat Jaminan Akhir"** adalah surat yang diterbitkan oleh Pihak Pertama secara elektronik, dimana Pihak Pertama melakukan verifikasi kelengkapan dokumen klaim, informasi medis, dan biaya Pelayanan Kesehatan yang ditanggung atau tidak ditanggung selama Peserta menerima Pelayanan Kesehatan di Faskes, dalam bentuk yang secara substansial terlampir dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.
15. **"Monitoring Harian"** adalah skema di mana Pihak Pertama melakukan pengawasan dan akses untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh dari Pihak Kedua, termasuk tetapi tidak terbatas pada tagihan administrasi, laporan medis, rencana pengobatan dan rencana perawatan dari setiap Peserta.
16. **"Web Portal"** adalah fasilitas aplikasi *website (website application)* yang dimiliki dan digunakan oleh Pihak Pertama untuk melakukan verifikasi, pendaftaran, dan pengecekan status manfaat Peserta, serta pembayaran dan fitur lainnya yang disediakan dan diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dari waktu ke waktu.
17. **"Daftar Tarif"** adalah suatu daftar yang berisi tarif-tarif/biaya dari Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua di Faskes.
18. **"Harga Netto Apotek"** atau **"HNA"** adalah harga dasar obat yang ditetapkan oleh distributor dan menjadi acuan bagi Pihak Pertama untuk menentukan harga jual apotek atas obat-obatan yang dipergunakan Peserta.
19. **"Jaminan Kesehatan Nasional"** yang selanjutnya disingkat **"JKN"** adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

20. **“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”** yang selanjutnya disingkat **“BPJS Kesehatan”** adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan program JKN.
21. **“Indonesian-Case Base Group”** atau **“INA-CBG”** adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur, penentuan tarif, atau biaya pelayanan sesuai dengan kelompok tersebut.
22. **“Tenaga Kesehatan”** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan yang dipekerjakan dan/atau bekerja sama dengan Pihak Kedua di Faskes.
23. **“Hari Kalender”** adalah setiap hari Senin sampai dengan Minggu pada kalender Masehi, tidak mempertimbangkan hari libur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
24. **“Hari Kerja”** adalah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali tanggal merah atau hari libur Nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
25. **“Surat Penolakan Penjaminan”** adalah surat yang diterbitkan secara elektronik oleh Pihak Pertama saat ditemukan bahwa informasi-informasi terkait Pelayanan Kesehatan atas Peserta yang diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua termasuk ke dalam kondisi pengecualian atau tidak dijamin oleh Pihak Pertama. Surat Penolakan Penjaminan mencabut Surat Jaminan Awal, sehingga Pelayanan Kesehatan yang sudah diperoleh oleh Peserta sebelumnya, merupakan tanggungan Peserta.
26. **“Coordination of Benefit untuk BPJS Kesehatan”** atau **“COB BPJS”** adalah suatu jenis layanan pemanfaatan fasilitas JKN dari BPJS Kesehatan, dimana BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama dan Pihak Pertama sebagai penjamin kedua.
27. **“Formularium Pihak Pertama”** adalah daftar obat yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama yang direkomendasikan dan disetujui untuk digunakan oleh Pihak Kedua saat Peserta memperoleh Pelayanan Kesehatan.

PASAL 2 – RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua ke Peserta dapat mencakup:
 - a. Pelayanan Gawat Darurat
 - b. Pelayanan Rawat Inap, termasuk :
 - kamar perawatan;
 - operasi/ tindakan pembedahan;
 - pemeriksaan penunjang medis;
 - obat-obatan; dan
 - hal-hal lain yang berhubungan dengan kepentingan pengobatan dan indikasi medis.
 - c. Pelayanan Rawat Jalan, termasuk:
 - konsultasi dokter spesialis;
 - obat-obatan atas resep dokter;
 - pemeriksaan diagnostik; dan
 - fisioterapi.
 - d. Persalinan;
 - e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi;
 - f. Medical Check Up; dan/atau

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- g. Obat-obatan yang berhubungan dengan perawatan dan sesuai dengan Formularium Pihak Pertama dan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN);
 - h. Dalam hal Peserta berobat di Faskes dengan menggunakan fasilitas JKN dari BPJS Kesehatan, maka berlaku lingkup pelayanan, prosedur dan ketentuan JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Rincian Pelayanan Kesehatan yang disebutkan pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Web Portal dan/atau diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dari waktu ke waktu.
 3. Pihak Kedua memberikan Pelayanan Kesehatan di Faskes sesuai dengan Waktu Operasional.
 4. Dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dan melaksanakan Perjanjian ini, Pihak Kedua termasuk Faskes dan Tenaga Kesehatan harus tunduk dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan kode etik kedokteran.
 5. Kualitas dari Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua dan/atau perwakilannya, termasuk namun tidak terbatas pada Tenaga Kesehatan di Faskes, kepada Peserta dan pihak lain, sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua. Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin serta membebaskan Pihak Pertama dari segala kerugian, tuntutan, gugatan, dan hal-hal lain yang disebabkan oleh kualitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Pihak Kedua dan/atau perwakilannya termasuk namun tidak terbatas pada Tenaga Kesehatan, kepada pasiennya dan pihak lain.
 6. Bagi Peserta yang memerlukan Pelayanan Kesehatan lebih lanjut, yang mana layanan tersebut tidak tersedia di Faskes, maka Peserta akan dirujuk ke Faskes Rekanan yang ditentukan oleh Pihak Pertama. Dalam hal ini, Pihak Kedua akan menerbitkan suatu Surat Rujukan.
 7. Dalam hal Peserta menggunakan fasilitas JKN dari BPJS Kesehatan, maka berlaku COB BPJS, dimana BPJS Kesehatan merupakan penjamin pertama dan Pihak Pertama merupakan penjamin kedua.

PASAL 3 – PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Prosedur serta syarat dan ketentuan Pelayanan Kesehatan adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.

PASAL 4 – HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama
 - a. Peserta Pihak Pertama berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan setiap saat diperlukan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
 - b. Pihak Pertama wajib membayar tagihan biaya Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
 - c. Pihak Pertama berhak untuk melakukan monitoring atas Peserta yang sedang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Faskes, dan dalam hal ditemukan bahwa informasi terkait kondisi dari dan Pelayanan Kesehatan yang diterima Peserta tidak dijamin oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat menerbitkan Surat Penolakan Penjaminan yang mencabut Surat Jaminan Awal, dan Pelayanan Kesehatan yang sudah diperoleh oleh Peserta merupakan tanggungan Peserta.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- d. Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi medis atas Peserta secara lengkap dan benar.
- e. Pihak Pertama berhak atas akses komunikasi dengan dokter di Faskes yang menangani Peserta dan/atau dokter penanggung jawab yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
- f. Pihak Pertama berhak mendapatkan Daftar Tarif yang paling terbaru dan berlaku dari Pihak Kedua dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- g. Pihak Pertama berhak menolak biaya Pelayanan Kesehatan yang ditagihkan oleh Pihak Kedua apabila terdapat kesalahan penjaminan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
- h. Pihak Pertama berhak melakukan investigasi kepada Pihak Kedua atas kasus-kasus kecurangan dan/atau penyalahgunaan.
- i. Pihak Pertama dapat melakukan peninjauan (review), memberikan masukan dan arahan atas jasa dan pelayanan yang diberikan oleh Pihak Kedua, termasuk sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan, serta kinerja Pihak Kedua dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka memastikan hak-hak Peserta dan Pihak Pertama.

2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua wajib menyediakan kontak yang dapat setiap saat dihubungi oleh Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berhak mendapatkan pembayaran atas biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta.
- c. Pihak Kedua wajib memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sesuai dengan standar yang berlaku di Faskes, standar tenaga serta alat yang dimiliki oleh Pihak Kedua di Faskes.
- d. Pihak Kedua akan merujuk Peserta ke Faskes Rekanan atas persetujuan dari Pihak Pertama, apabila fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diperlukan tidak tersedia di Faskes.
- e. Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama dalam penekanan biaya yang timbul dari setiap Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta dan memastikan bahwa Pelayanan Kesehatan dan biayanya tersebut adalah yang paling efisien.
- f. Pihak Kedua wajib memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pihak Kedua wajib memastikan bahwa seluruh alat kesehatan, sediaan farmasi, obat-obatan dan produk lainnya yang disediakan dan digunakan di Faskes telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pihak Kedua akan melepaskan tanggung jawab Pihak Pertama dan menggantikan segala kerugian Pihak Pertama dalam hal terjadi tuntutan/gugatan atau klaim dalam bentuk apa pun terhadap Pihak Pertama sehubungan dengan pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Pihak Kedua.
- i. Pihak Kedua melepaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau klaim apa pun dari pihak mana pun sehubungan dengan keaslian, keabsahan, keberlakuan dokumen perizinan milik Pihak Kedua.
- j. Pihak Kedua bertanggung jawab atas seluruh Pelayanan Kesehatan dan tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan karyawan dan seluruh Tenaga Kesehatan Pihak Kedua.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- k. Pihak Kedua wajib menginfokan dan mengirimkan Formulir LMA yang sudah dilengkapi beserta dengan hasil pemeriksaan penunjang ke Pihak Pertama dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak Peserta mulai dirawat.
- l. Pihak Kedua wajib membantu pelaksanaan Monitoring Harian untuk kepentingan perawatan dan menginformasikan perkembangan Peserta kepada Pihak Pertama.
- m. Pihak Kedua wajib mengirimkan rincian biaya perawatan Peserta beserta resume medis akhir Peserta secara lengkap melalui e-mail sebelum Peserta meninggalkan Faskes untuk dapat diverifikasi terlebih dahulu oleh Pihak Pertama.
- n. Pihak Kedua berkewajiban menagih langsung kepada Peserta atas selisih biaya yang timbul sebelum Peserta meninggalkan Faskes sesuai dengan Struk Discharge dan/atau Surat Persetujuan Pembayaran yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab apabila Pihak Kedua tidak melakukan penagihan atas kelebihan biaya yang tidak dijaminan kepada Peserta.
- o. Pihak Kedua wajib memberitahukan Pihak Pertama apabila terdapat perubahan prosedur Pelayanan Kesehatan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan prosedur Pelayanan Kesehatan dimaksud.
- p. Pihak Kedua wajib memberikan segala bentuk informasi dan data medis yang relevan dengan kondisi medis Peserta, termasuk secara elektronik, selama Peserta mendapat Pelayanan Kesehatan di Faskes kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menjamin bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan Pihak Kedua dari segala klaim/gugatan/tuntutan dari pihak mana pun sehubungan dengan pembukaan informasi dan data medis Peserta Pihak Pertama untuk tujuan Perjanjian ini.
- q. Dalam hal menggunakan Web Portal, Pihak Kedua wajib menyediakan sarana, prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mengakses dan menggunakan Web Portal.

Commented [A1]:

PASAL 5 – PENYEDIAAN OBAT-OBATAN

Pihak Kedua menyediakan alat kesehatan dan obat-obatan yang dibutuhkan selama Pelayanan Kesehatan diberikan kepada Peserta di Faskes, dengan mengacu atau memprioritaskan penggunaan standarisasi Formularium Pihak Pertama. Apabila terdapat obat di luar Formularium Pihak Pertama yang dibutuhkan sesuai indikasi medis, maka Pihak Kedua wajib terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Pihak Pertama.

PASAL 6 – BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

1. Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Peserta akan dikenakan tarif standar sesuai dengan yang berlaku di Faskes pada saat Pelayanan Kesehatan diberikan dan sesuai dengan Daftar Tarif yang diberikan kepada Pihak Pertama. Khusus untuk biaya obat-obatan dan sediaan farmasi, Para Pihak sepakat bahwa harga pembayaran yang akan ditagihkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tidak lebih besar dari Harga Netto Apotek (HNA) x 1,25 + PPN ("**Biaya Pelayanan Kesehatan**").
2. Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta dapat ditagihkan dan dibayarkan melalui Pihak Pertama, dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 Perjanjian ini.
3. Setiap perubahan terhadap Daftar Tarif Pelayanan Kesehatan wajib diberitahukan kepada Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Daftar Tarif baru berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

4. Dalam hal terjadi perbedaan di antara Para Pihak sehubungan Daftar Tarif mana yang berlaku, maka Daftar Tarif yang terakhir diberikan ke Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan Pasal ini yang berlaku.
5. Kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua dalam memenuhi ketentuan Pasal ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab Pihak Kedua.

PASAL 7 – JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun, berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 ~~hohon is~~ sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 ~~hohon is~~, dan akan secara otomatis diperbaharui kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai ketentuan Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dapat pula diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran apabila:
 - a. Berdasarkan instruksi, dekrit, ketentuan/peraturan pemerintah atau keputusan instansi yang berwenang, kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. Salah satu Pihak dicabut izin usahanya, dilikuidasi atau karena alasan apa pun tidak dapat menjalankan usahanya secara sebagian atau keseluruhan, atau menjadi insolven atau pailit atau permintaan, tuntutan atau gugatan untuk dinyatakan insolven, penundaan pembayaran hutang atau pailit diajukan terhadap Pihak tersebut baik oleh Pihak tersebut sendiri maupun oleh krediturnya; atau
 - c. Dalam hal terjadinya pelanggaran atas kewajiban dan/atau pernyataan dan jaminan oleh salah satu Pihak dan Pihak yang melakukan pelanggaran telah diberikan pemberitahuan tertulis atas pelanggaran tersebut oleh Pihak lainnya, dan Pihak yang melakukan pelanggaran tidak dapat memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak pemberitahuan tertulis tersebut diterima oleh Pihak yang melakukan pelanggaran.
4. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri karena alasan sebagaimana tercantum dalam ayat 3 poin c tersebut di atas, maka Pihak yang melakukan pelanggaran berkewajiban untuk mengganti kerugian nyata yang dialami oleh Pihak yang tidak melakukan pelanggaran.
5. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat hak - hak dan kewajiban - kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai Perjanjian ini berakhir, maka hak dan kewajiban Para Pihak tersebut wajib dipenuhi atau diselesaikan oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
6. Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 8 – KERAHASIAAN

1. Dalam Perjanjian ini, “Informasi Rahasia” adalah seluruh informasi non-publik dan rahasia yang dibuka oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya, baik secara lisan, tulisan, yang memiliki bentuk fisik maupun elektronik.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Setiap Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pihak yang mengungkapkan ("**Pihak Pengungkap**") kepada Pihak yang menerima ("**Pihak Penerima**") dan/atau yang diperoleh Pihak Penerima sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini, wajib dijaga kerahasiaannya sekalipun Perjanjian ini telah berakhir.
3. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari yang dialami Pihak Pengungkap merupakan tanggung jawab Pihak Penerima sepenuhnya.
4. Masing-masing Pihak, tanpa melanggar Perjanjian ini, tidak dilarang untuk membuka Informasi Rahasia yang:
 - a. Sudah diketahui terlebih dahulu oleh salah Pihak lainnya, tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan;
 - b. Sudah diketahui oleh publik atau menjadi pengetahuan umum bukan karena tindakan yang tidak sah atau kegagalan oleh Pihak lainnya;
 - c. Disetujui secara tertulis oleh Pihak Pengungkap untuk dibuka oleh Pihak Penerima;
 - d. Dikembangkan secara independen oleh Pihak Penerima tanpa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan pada Perjanjian ini;
 - e. Diwajibkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan, pemerintah, putusan atau hukum, peraturan atau peraturan-perundang-undangan, atau oleh pengadilan, instansi pemerintah, legislatif, pengawas, pengatur atau otoritas, badan atau komite yang memiliki yurisdiksi salah satu Pihak, atau sesuai dengan proses hukum atau peradilan yang berlaku (selanjutnya disebut sebagai "**Hukum**"); atau
 - f. Tersedia atau menjadi tersedia untuk Pihak Penerima berdasarkan ketidakrahasiaan dari sumber lain selain Pihak Penerima, di mana Pihak Penerima tidak mengetahui bahwa sumber lain tersebut terikat dengan Pihak Pengungkap untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut.
5. Dalam hal pembukaan Informasi Rahasia oleh Pihak Penerima oleh Hukum, maka Pihak Penerima harus dengan segera memberitahukan kepada Pihak Pengungkap, agar Pihak Pengungkap memiliki kesempatan untuk melindungi kerahasiaan Informasi Rahasia, sehingga Informasi Rahasia dan/atau dokumen-dokumen yang diungkapkan dapat digunakan hanya untuk tujuan sebagaimana diperintahkan oleh Hukum, dan Pihak Penerima dengan usaha yang wajar akan meminimalisir pengungkapan tersebut dan hanya akan melengkapi bagian dari Informasi Rahasia yang secara Hukum diperintahkan untuk diungkapkan.
6. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa seluruh pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan serta pengiriman data Peserta, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi dan rekam medis, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi dan rekam medis.

PASAL 9 – KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kendali wajar, tidak dapat diantisipasi dan tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah, kerusuhan, perang, embargo, banjir, gempa bumi, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi Para Pihak secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Para Pihak sepakat bahwa apabila salah satu Pihak mengalami kejadian Keadaan Kahar, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dan Para Pihak harus segera berunding untuk menentukan penyelesaian selanjutnya.
3. Apabila kejadian Keadaan Kahar tidak memungkinkan Para Pihak untuk melanjutkan Perjanjian ini maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah dan mengakhiri Perjanjian ini.
4. Tidak ada Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan atau tertundanya pelaksanaan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian ini apabila kesalahan atau penundaan tersebut terjadi akibat suatu Keadaan Kahar.

PASAL 10 – PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak sesuai dengan anggaran dasarnya atau berdasarkan surat kuasa yang dibuat dan diberikan oleh direksi perusahaan Pihak yang bersangkutan.
2. Para Pihak telah memiliki dan akan mempertahankan keberlakuan seluruh perizinan, persetujuan dan persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instansi yang berwenang.
3. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa alat kesehatan, sediaan farmasi, obat-obatan dan produk lainnya yang disediakan dan digunakan di Faskes telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan Pihak Kedua menjamin dan membebaskan Pihak Pertama dari seluruh kewajiban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan ayat ini.
4. Masing-masing Pihak tidak terlibat dalam sengketa, atau terdapat proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
5. Para Pihak menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini tidak bertentangan dengan perjanjian apa pun yang telah dibuat oleh dan antara masing-masing Pihak dengan pihak ketiga.
6. Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa selama menjalankan Perjanjian ini, Pihak Kedua harus tunduk dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, perlindungan data pribadi, dan kode etik kedokteran.
7. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa seluruh Pelayanan Kesehatan yang ada dan disediakan di Faskes sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
8. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa seluruh tenaga kesehatan di Faskes telah memiliki dan akan mempertahankan keberlakuan seluruh perizinan, persetujuan dan persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instansi yang berwenang.
9. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan diagnosa Peserta, sesuai dengan standar yang berlaku, dan tidak disalahgunakan oleh Peserta dan/atau Para Pihak dan/atau pihak lain.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

10. Para Pihak menyatakan dan menjamin akan melaksanakan serta memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan sikap profesionalisme.
11. Para Pihak dengan ini menyetujui dan menyanggupi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin akan mematuhi syarat dan ketentuan penggunaan Web Portal.
13. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apa pun.
14. Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas adalah dan akan tetap benar/akurat dan dipatuhi selama berlakunya Perjanjian ini.

PASAL 11 - KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan, permohonan atau korespondensi dari suatu Pihak kepada Pihak lain harus dilakukan secara tertulis dan diberikan ke alamat korespondensi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian ini.
2. Semua pemberitahuan, permohonan atau korespondensi dari suatu Pihak kepada Pihak lain yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini akan dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada tanggal pengiriman, dalam hal disampaikan secara langsung dengan bukti penerimaan yang memadai;
 - b. pada tanggal pengiriman, dalam hal pengiriman melalui faksimile atau surat elektronik, pada jam kerja penerima, jika tidak, dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; atau
 - c. pada Hari Kerja ketiga sejak hari pengiriman dalam hal pengiriman menggunakan pos terdaftar ke alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
3. Perubahan keterangan korespondensi wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

PASAL 12 – HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
2. Segala dan semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak musyawarah pertama kali diadakan tidak tercapai mufakat di antara Para Pihak, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 13 – KETENTUAN ANTI KORUPSI DAN PENYUAPAN

1. Para Pihak akan berusaha keras untuk mempertahankan standar tertinggi dari perilaku moral dan etika. Tidak satu pun Pihak akan terlibat dalam segala bentuk praktik korupsi termasuk, namun tidak terbatas pada, pemerasan, penipuan, peniruan identitas, pernyataan palsu atau penyuapan.
2. Para Pihak harus segera memberitahukan satu sama lain, jika mengetahui atau memiliki kecurigaan adanya tindakan korupsi berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan Perjanjian ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

3. Dalam hal terbukti salah satu Pihak, termasuk karyawannya, agennya dan/atau perwakilannya terbukti telah memberikan manfaat atau bujukan, baik secara finansial atau dalam bentuk apa pun kepada karyawan Pihak lainnya dan/atau perusahaan afiliasi dan anak perusahaannya, masing-masing termasuk juga anggota keluarga mereka masing-masing, di mana keuntungan atau bujukan tersebut dimaksudkan (atau mungkin ditafsirkan secara wajar untuk dimaksudkan demikian), baik secara langsung atau tidak langsung, untuk menarik, membujuk, mempengaruhi secara tidak sah, menyogok, memaksakan, mewajibkan, atau lainnya yang dapat mempengaruhi hasil dari setiap tender dan/atau kontrak atau perjanjian apa pun dan/atau penyerahan-penyerahan dan/atau pelaksanaan/kontrak, maka Pihak yang tidak melakukan hal tersebut dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera.

PASAL 14 - KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak mana pun oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
2. Hal – hal yang belum atau kurang cukup diatur dalam Perjanjian ini apabila dikemudian hari dipandang perlu akan ditetapkan secara tersendiri dan tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam suatu lampiran yang menjadi adendum atau amandemen dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
3. Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini di masa yang akan datang harus didasarkan pada persetujuan tertulis bersama Para Pihak, dan perubahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Pihak Kedua wajib memberikan pemberitahuan tertulis apabila terdapat penambahan cabang Faskes yang akan diikutsertakan dalam Perjanjian ini, untuk disetujui oleh Pihak Pertama. Setiap cabang Faskes yang diikutsertakan dalam Perjanjian ini wajib tunduk, patuh dan terikat terhadap keseluruhan ketentuan dalam Perjanjian ini.
5. Setiap ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini yang tidak berlaku, tidak dapat dilaksanakan atau dibatalkan akan menjadi tidak berlaku, dan ketidakberlakuan, tidak dapat dilaksanakannya atau pembatalan tersebut tidak akan membatalkan atau mengakibatkan tidak berlakunya ketentuan lain dalam Perjanjian ini. Para Pihak setuju untuk menggantikan setiap ketentuan yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau dibatalkan tersebut dengan ketentuan-ketentuan lain yang mengikat, sah dan dapat dilaksanakan.
6. Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan suatu hak dan upaya yang dimilikinya terhadap Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan pelepasan hak dari Pihak tersebut untuk melaksanakan hak dan upaya tersebut kapan pun.
Pengesampingan salah satu Pihak atas pemenuhan atau pelaksanaan suatu syarat atau ketentuan Perjanjian ini, atau pelanggaran terhadap suatu janji, dari persetujuan kewajiban atau ketentuan tercantum atau tersirat dalam Perjanjian ini, setiap waktu, tidak akan berlaku sebagai pengesampingan atas pemenuhan atau pelaksanaan suatu ketentuan, syarat atau pelanggaran terhadap syarat atau ketentuan tersebut atau suatu janji, kewajiban atau ketentuan lain yang tercantum atau tersirat dalam Perjanjian ini di kemudian hari. Oleh karena itu, suatu pelepasan hak salah satu Pihak untuk menuntut atas hal-hal tersebut di atas tidak boleh dianggap sebagai pengesampingan atas hak-haknya sehubungan dengan suatu pelanggaran Pihak lainnya terhadap Perjanjian ini.
7. Perjanjian ini dan seluruh lampirannya merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak mengenai hal pokok yang diatur di dalamnya dan menggantikan dan membatalkan dalam segala

Pihak Pertama	Pihak Kedua

FKTL-I

hal semua pernyataan, jaminan, perjanjian dan janji, jika ada, yang dibuat antara Para Pihak sehubungan dengan pokok Perjanjian ini baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

8. Semua lampiran pada Perjanjian ini harus dibaca dan ditafsirkan sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

[Sisa halaman ini sengaja dibiarkan kosong]

Pihak Pertama	Pihak Kedua

FKTL-I

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

PT ASURANSI JIWA TEGUH PELITA PELINDUNG

[mohon isi]

Direktur

PIHAK KEDUA

PT DISA PRIMA MEDIKA [mohon isi nama badan hukum]

[mohon isi] ENDANG SUSILOWATI

[mohon isi jabatan] — DIREKTUR UTAMA

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN 1 – KORESPONDENSI

KORESPONDENSI PIHAK PERTAMA

PT ASURANSI JIWA TEGUH PELITA PELINDUNG**Sehubungan dengan Provider Relation:**

Nama : Rika Deasyantie

Jabatan: Supervisor Provider Relation & Sales

Alamat : Sinarmas Land Plaza, Menara 2, Lantai 18

Jl. MH Thamrin No 51, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350

Telp. : 0813-9838-6189

Email : rika.deasyantie@kliniksehatq.com

Nama : Hendriana

Jabatan : Provider Relation & Sales Specialist

Alamat : Sinarmas Land Plaza, Menara 2, Lantai 18

Jl. MH Thamrin No 51, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350

Telp. : 0813-11875266

Email : hendriana@kliniksehatq.com**Sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan dan verifikasi (“Tim Verifikator”):**

Nama : Renya Sani

Jabatan : Analis Claim Coordinator

Alamat : Ruko Jl. Duyung No. 100 F, Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28124

No. Telp: 0821-1784-9898

Email : Verifikator_pku@kliniksehatq.com

Nama : Rama Eko

Jabatan : Cashless Verificator Claim Coordinator

Alamat : Ruko Jl. Duyung No. 100 F, Kelurahan Tangkerang Barat,

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28124

No. Telp: 0838-7527-8077

Sehubungan dengan penagihan dan pembayaran:

Nama : Divisi Finance/Keuangan

Alamat : Sinarmas Land Plaza, Menara 2, Lantai 18

Jl. MH Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10350

Email : finance@kliniksehatq.com

FASKES DAN KORESPONDENSI PIHAK KEDUA

[nama lengkap Faskes sesuai SIO]PT DISA PRIMA MEDIKABanjjararum Selatan No.3 Mondoroko, Kecamatan Singosari, kabupaten Malang, Jawa Timur

Pihak Pertama	Pihak Kedua

<u>RS PRIMA HUSADA MALANG</u> <u>Banjararum Selatan No 3-7 Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur</u> <u>RS PRIMA HUSADA SUKOREJO</u> <u>Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur</u> <u>{alamat lengkap Faskes sesuai SIO}</u> Waktu Operasional: <u>{mohon isi}</u> 24 Jam Jenis Pelayanan Kesehatan yang disediakan adalah sesuai dengan ketersediaan di masing-masing Faskes. Contact Person: <u>Nama : {mohon isi}</u> <u>Jabatan : {mohon isi}</u> <u>Alamat : {mohon isi}</u> <u>No. Telp: {mohon isi}</u> <u>Email : {mohon isi}</u>	
<u>RS PRIMA HUSADA MALANG</u> <u>Sehubungan dengan</u> <u>Pelayanan Kesehatan dan verifikasi:</u> <u>Nama : {mohon isi}</u> <u>Jabatan : {mohon isi}</u> <u>Alamat : {mohon isi}</u> <u>No. Telp: {mohon isi}</u> <u>Email : {mohon isi}</u>	<u>RS PRIMA HUSADA SUKOREJO</u> <u>Sehubungan</u> <u>dengan penagihan dan pembayaran:</u> <u>Nama : {mohon isi}</u> <u>Jabatan : {mohon isi}</u> <u>Alamat : {mohon isi}</u> <u>No. Telp: {mohon isi}</u> <u>Email : {mohon isi}</u>
<u>Sehubungan dengan MOU</u> <u>Nama : Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns</u> <u>Jabatan : Humas & Marketing</u> <u>Alamat : Banjararum Selatan No 3-7,</u> <u>Mondoroko, Kec.Singosari, Kab.Malang, Jawa</u> <u>Timur</u> <u>No. Telp: 0811 3507 164</u> <u>Email : marketingsphm@gmail.com</u>	<u>Sehubungan dengan MOU</u> <u>Nama : Lidia Emilinda, S.Tr.Keb.,M.MRS</u> <u>Jabatan : Humas & Marketing</u> <u>Alamat : Jl. Surabaya – Malang Km 54,</u> <u>Lemahbang, Kec.Sukorejo, Kab.Pasuruan,</u> <u>Jawa Timur</u> <u>No. Telp: 0813 1557 4065</u> <u>Email : backupdatamarketingphs@gmail.com</u>
<u>Sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan dan</u> <u>verifikasi:</u> <u>Nama : Lilik Kurniati</u> <u>Jabatan : Admin Jaminan</u>	<u>Sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan</u> <u>dan verifikasi:</u> <u>Nama : Hanik Amalia, S.E</u> <u>Jabatan : Admin Jaminan</u>

Formatted: Not Highlight

Formatted: Normal, Justified

Pihak Pertama	Pihak Kedua

FKTL-I

<u>Alamat : Banjararum Selatan No 3-7, Mondoroko, Kec.Singosari, Kab.Malang, Jawa Timur</u> <u>No. Telp: 0813 3142 9720</u> <u>Email : admklaim.rsph@gmail.com</u>	<u>Alamat : Jl. Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kec.Sukorejo, Kab.Pasuruan, Jawa Timur</u> <u>No. Telp : 0821 4203 6398</u> <u>Email : keuanganrsphs@gmail.com</u>
<u>Sehubungan dengan penagihan dan pembayaran:</u> <u>Nama : Novi Ratnasari, S.E</u> <u>Jabatan : Kepala Unit Keuangan</u> <u>Alamat : Banjararum Selatan No 3-7, Mondoroko, Kec.Singosari, Kab.Malang, Jawa Timur</u> <u>No. Telp: 0823 3580 0485</u> <u>Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com</u>	<u>Sehubungan dengan penagihan dan pembayaran:</u> <u>Nama : Anita Sari, S.E</u> <u>Jabatan : Kepala Unit Keuangan</u> <u>Alamat : Jl. Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kec.Sukorejo, Kab.Pasuruan, Jawa Timur</u> <u>No. Telp: 0851 5600 1411</u> <u>Email : keuangan@sukorejo.rs-primahusada.com</u>

Pihak Pertama	Pihak Kedua

FKTL-I

LAMPIRAN 2 – DOKUMEN-DOKUMEN

Commented [LS2]: To PIC: Mohon dilengkapi.

A. KARTU PESERTA

BUDI SANTOSA

LAKI - LAKI

ID Karyawan

400365

Kode Plan

IP-500; OP-KM600;



Member ID

060234000026

Pihak Pertama	Pihak Kedua

FKTL-I

B. SURAT JAMINAN AWAL

SURAT JAMINAN

Kepada	:	EKA HOSPITAL PEKANBARU	Tanggal	:	17-09-2024
Email	:		Nomor	:	24091700000174
Penerima	:	ADM RI			

Bersama ini kami dari PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung bertindak sebagai penjamin mengeluarkan Surat Jaminan rawat inap atas nama Pasien sebagai berikut:

Jenis Surat Jaminan : SURAT JAMINAN AWAL
Nama Peserta :
Jenis Kelamin :
Tanggal Lahir :
Company :
No. Member : 0900440000013026
Hak Kamar : -
Diagnosa : J06.9 K30
DPJP : dr. Hady, Sp.PD
Nama Tindakan :
Tanggal Tindakan :

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Surat ini dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung sebagai konfirmasi bahwa pasien yang bersangkutan berhak mendapatkan pelayanan medis dan surat ini tidak menjadi acuan besaran biaya yang dijamin oleh PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung.
2. Surat jaminan ini berlaku hanya untuk diagnosa yang tercantum di atas. Mohon menghubungi PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung apabila ada perubahan diagnosa dan diagnosa tambahan.
3. Rumah sakit wajib menghubungi PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung sebelum pasien meninggalkan rumah sakit agar pihak rumah sakit dapat mengetahui biaya apa saja yang dijamin oleh PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung. Jika pasien meninggalkan rumah sakit sebelum mengkonfirmasi ke PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung, maka PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung tidak bertanggung jawab atas biaya yang tidak dijamin.
4. Pasien bertanggung jawab untuk menyelesaikan secara langsung kepada pihak rumah sakit dan penyedia jasa medis apabila terjadi selisih biaya (ekses) atas seluruh biaya perawatan, biaya medis, dan yang lain yang telah terjadi sehubungan dengan rawat inap, maupun atas

Verification & Claim - PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung
Sinarmas Land Plaza Tower II – 18th Floor, J.L.M.H. Thamrin No.51,
Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia
P : +62 21 3921 1001
E : verifikator_pku@kliniksehatq.com

Hormat Kami,

Menyetujui

.....
(Verification & Claim)

.....
(Name & Signature pasien)
(Pasien/Keluarga)

PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung
Sinarmas Land Plaza Tower II – 18th Floor, J.L.M.H. Thamrin No.51,
Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia
Phone. +62 21 3921 1001

Pihak Pertama	Pihak Kedua

FKTL-I

Pihak Pertama	Pihak Kedua

FKTL-I

C. LAPORAN MEDIS AWAL

LAPORAN MEDIS AWAL

Teman sejawat yang terhormat, mohon untuk melengkapi laporan medis awal berikut, max 2X24 jam, guna proses penjaminan pasien.

Terima kasih atas kerjasamanya.

Nama Pasien :	Penjamin :
Tempat, Tanggal lahir :	RS :
Jenis Kelamin :	Tanggal Masuk Rawat :
No. KTP :	Biaya Kamar perhari :
Perusahaan :	Dokter yang merawat :

DATA MEDIS PASIEN

Anamnesa/Keluhan pasien	:	
Sejak kapan keluhan dirasakan	:	
Riwayat penyakit sebelumnya	:	
Hasil Pemeriksaan Fisik	:	
TTV	:	GCS (E/V/M) : S:___°C TD:___MMHg HR:___x/m RR:___x/m Skala Nyeri (VAS):___
Jika tumor sebutkan ukuran dan regio	:	
Hasil Pemeriksaan Penunjang	:	
Diagnosa	:	
Penyebab/Etiologi	:	
Indikasi rawat inap	:	
Perkiraan lama perawatan	:	Hari
Rencana terapi	:	Oral : Injeksi : Infus :
Rencana Tindakan/Operasi	:	Nama Tindakan : Jenis Tindakan : () Cito () Elektif Jenis anastesi : () Lokal () Umum
Kategori Operasi	:	() Kompleks () Besar () Sedang () Kecil
Apakah perawatan dapat dilakukan secara rawat jalan?	:	() Ya () Tidak, jika tidak mohon penjelasannya :
Apakah perawatan dapat dilakukan secara One day care?	:	() Ya () Tidak, jika tidak mohon penjelasannya :
Apakah Diagnosa berhubungan dengan	:	() Kongenital () Fertilitas/kesuburan () Alkohol/Penggunaan obat-obatan terlarang () Hereditas () Olahraga Berbahaya () Huru hara () Psikososial/kejiwaan () Usaha bunuh diri () Sexually Transmitted Diseases () HIV/AIDS/ARC () Menurunkan/menaikan berat badan () Kosmetik

.....
Dokter yang merawat,

()
Nama DPJP, Stempel RS dan DPJP.

PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung
Sinarmas Land Plaza Tower II – 18th Floor, Jl.M.H.Thamrin
No.51,Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia
Phone. +62 21 3921 1001

Pihak Pertama	Pihak Kedua

FKTL-I

|

Pihak Pertama	Pihak Kedua

FKTL-I

D. SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN atau SURAT JAMINAN AKHIR

SURAT JAMINAN

Kepada	:	HOSPITAL PEKANBARU	Tanggal	:	30-10-2024 s/d 14-11-2024
Email	:		Nomor	:	
Penerima	:	ADM RI			

Bersama ini kami dari PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung bertindak sebagai penjamin mengeluarkan, Surat Jaminan rawat inap atas nama Pasien sebagai berikut:

Jenis Surat Jaminan : SURAT JAMINAN AKHIR
Nama Peserta : HARSANA

Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : 01-06-1771
Company : PT. INDAH
No. Member : 1908440000024
Hak Kamar : 1

Diagnosa : N18.9-Chronic renal failure, unspecified | N18.9-Chronic renal failure, unspecified | A41.9-Septicaemia, unspecified
DJP : dr. Roberto
Kode inacbs : H-4-12-III

RINCIAN PENGESAHAN

BENEFIT	Total Biaya Perawatan	Total Biaya dijaminan Asuransi	Total Biaya dijaminan BPJS / Ekses Provider	Total Ekses Peserta
RAIAT INAP	7,738,050.00	7,511,540.00	10,317,400.00	226,510.00

Keterangan Ekses :
MECOBALAMIN 500MCG 18.000, ASAM FOLAT 1MG 9.450, ANTI DECUBITUS MATRAS 160.000, NASAL CANNULA,ADULT,ESKAMED 39.060

SYARAT DAN KETENTUAN

- Surat ini dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung sebagai konfirmasi bahwa pasien yang bersangkutan berhak mendapatkan pelayanan medis dan surat ini tidak menjadi acuan besaran biaya yang dijaminan oleh PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung
- Surat jaminan ini berlaku hanya untuk diagnosa yang tercantum di atas. Mohon menghubungi PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung apabila ada perubahan diagnosa dan diagnosa tambahan.
- Rumah sakit wajib menghubungi PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung sebelum pasien meninggalkan rumah sakit agar pihak rumah sakit dapat mengetahui biaya apa saja yang dijamin oleh PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung. Jika pasien meninggalkan rumah sakit sebelum mengkonfirmasi ke PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung, maka PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung tidak bertanggung jawab atas biaya yang tidak dijaminan.
- Pasien bertanggung jawab untuk menyelesaikan secara langsung kepada pihak rumah sakit dan penyedia jasa medis apabila terjadi selisih biaya (ekses) atas seluruh biaya perawatan, biaya medis, dan yang lain yang telah terjadi sehubungan dengan rawat inap, maupun atas perhal perawatan medis yang tidak tercakup dalam ketentuan pelayanan kesehatan dikarenakan karena alasan apapun.

Verification & Claim - PT. ASURANSI JIWA TEGUH PELITA PELINDUNG
Sinarmas Land Plaza Tower II – 18th Floor, JLM.H.Thamrin No.51,
Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia
P : +62 21 3921 1001
E : verifikator_pku@kliniksehatq.com

Hormat Kami,

Menyetujui

Abode
(Verification & Claim)

(Nama & Signature pasien)
(Pasien/Keluarga)

PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung
Sinarmas Land Plaza Tower II – 18th Floor, JLM.H.Thamrin No.51,
Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia
Phone. +62 21 3921 1001

Pihak Pertama	Pihak Kedua

FKTL-I

E. FORMULIR RAWAT JALAN

PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung
 Sinarmas Land Plaza Tower II – 18th Floor,
 Jl.M.H.Thamrin No.51, Jakarta Pusat, 10350.
 +62 21 3921 1001, +62 21 3921 1001
 verifikasi_plu@kliniskehatq.com
<https://www.sehatq.com>

FORMULIR KLAIM RAWAT JALAN

Nama RS/Klinik :				Tgl/Bln/Thn :			
DATA PASIEN							
Nama :				No. MR :			
Tanggal lahir / Umur :				Nama Perusahaan :			
Jenis Kelamin :				Tanggal :			
No. Kartu :							
INFORMASI MEDIS							
Tanda Vital :	Tensi :	Suhu :	Nadi :	RR :			
Diagnosa :							
Anamnesa :							
Pemeriksaan Fisik :							
TINDAKAN / TERAPI							
Tindakan Infus/ lainnya :							
Obat-obatan Injeksi :							
Obat-obatan Oral :							
PEMERIKSAAN PENUNJANG							
Laboratorium :							
Radiologi :							
Penunjang Lain :							
Bersama ini saya memberi kuasa kepada : - Dokter, Rumah Sakit / Klinik maupun institusi pelayanan medis lainnya untuk memberikan keterangan dan/ atau catatan medis, sehubungan dengan diagnosa dan/ atau pelayanan medis yang diberikan kepada saya dan keluarga saya yang menjadi Tertanggung, dan - PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung untuk mendapatkan segala keterangan/ catatan medis dari Rumah Sakit dan atau pihak lain sehubungan dengan diagnosa dan/ atau pelayanan medis yang diberikan kepada saya atau keluarga saya yang menjadi tertanggung, yang mana akan digunakan untuk memproses klaim sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku. Saya membebaskan PT. Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung dari segala kewajiban, tuntutan atau gugatan hukum apapun atas ditandatanganinya pernyataan ini. Seluruh keterangan yang tercantum dalam formulir klaim rawat jalan ini ditulis dengan benar dan saya menyadari bahwa salinan formulir klaim rawat jalan ini dapat berlaku sebagaimana mestinya							

Tanda Tangan Dokter, Nama Jelas dan Stempel RS

Tanda Tangan Pasien

(.....)

(.....)

Pihak Pertama	Pihak Kedua

FKTL-I

F. STRUK DISCHARGE

Nama Peserta	: MEMBER TESTING
No Kartu	: 1999800000000526
Tanggal Lahir	: 01-01-2000
No Polis	: KSQ0001
Tgl. Kunjungan	: (13-11-2024 s/d 14-11-2024)
Masa Polis	: (01-01-2022 s/d 31-12-2024)
Klien	: PT. SEHAT

****BIAYA PELAYANAN OUTPATIENT****

No Klaim	: 24111300000185
ICD10	: R50.0
Izin Sakit	: 1
Total Billing	: 1,100,000.00

****DIBAYAR PESERTA****

1. KONSULTASI DOKTER UMUM	Rp.	100,000.00
2. KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	Rp.	250,000.00
3. Konsultasi dan Obat Per Kunjungan	Rp.	750,000.0
T O T A L	Rp.	1,100,000.00

Term & Condition

- Eksek Bayar Ditempat
- Ke Dokter Spesialis Boleh Langsung
- Menjamin Vit& Suplement tidak berdiri sendiri
- Dikenakan Cosharing 10%

14/11/2024

.....TTD:.....
Re-Print


241113000001 5

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN 3 – PROSEDUR, SYARAT DAN KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN**1. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan****a. Dalam hal Pihak Kedua menggunakan Web Portal**

- (1) Sebelum memperoleh Pelayanan Kesehatan di Faskes, Peserta wajib menunjukkan Persyaratan Administrasi sebagai berikut:
 - (i) Kartu Peserta;
 - (ii) Bukti identitas diri Peserta, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - (iii) Rujukan dari Sistem BPJS Kesehatan (jika Peserta menggunakan fasilitas JKN);
 - (iv) Surat Rujukan (jika Peserta tidak menggunakan fasilitas JKN); dan
 - (v) Dokumen lain yang mungkin diperlukan sebagaimana diberitahukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
- (2) Pihak Kedua wajib melakukan verifikasi atas Persyaratan Administrasi dengan informasi Peserta yang tercantum dalam Web Portal dan memastikan bahwa Peserta yang datang sesuai dengan Persyaratan Administrasi yang dibawa.
- (3) Pihak Pertama akan melakukan verifikasi melalui Web Portal, dalam hal Web Portal tidak berfungsi karena alasan apa pun, maka Pihak Kedua dapat menghubungi Tim Verifikator Pihak Pertama.
- (4) Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta harus memperhatikan hak Peserta sesuai yang tercantum dalam Web Portal.
- (5) Setelah mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Pihak Kedua akan mengirimkan Form Rawat Jalan ke Pihak Pertama dan melakukan konfirmasi ke Pihak Pertama melalui Web Portal, dan Web Portal akan menerbitkan Struk Discharge.
- (6) Pihak Kedua wajib untuk mengisi secara detail dan lengkap Formulir Rawat Jalan yang sudah disediakan oleh Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini
- (7) Pihak Pertama berhak untuk melakukan verifikasi atas setiap Peserta yang berkunjung ke Faskes, termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan proses administratif, permintaan pemeriksaan penunjang dan terapi obat yang diberikan kepada Peserta.
- (8) Pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi) yang disarankan oleh dokter dan/atau Tenaga Kesehatan Faskes wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama melalui Web Portal (dilengkapi dengan tanda tangan Verifikator Pihak Pertama) sebelum memberikan pemeriksaan tersebut kepada Peserta.
- (9) Pemberian obat pada Peserta rawat jalan adalah maksimum untuk 7 (tujuh) hari pemakaian, dan dalam kasus diagnosa kronis maksimum untuk 30 (tiga puluh) hari pemakaian.
- (10) Untuk pemberian:
 - (i) Obat dengan harga lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per tablet/kapsul/vial/flacon;
 - (ii) Tindakan medis yang akan dilakukan dengan biaya lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - (iii) Tindakan medis dan/atau bedah yang akan dilakukan kepada Peserta;
 - (iv) Pemeriksaan laboratorium dan/atau radiologi lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - (v) Obat-obatan di luar dari Formularium Pihak Pertama,

Pihak Pertama	Pihak Kedua

wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama sebelum diberikan kepada Peserta.

- (11) Apabila terjadi selisih biaya ataupun ditemukan informasi diagnosa yang merupakan pengecualian dari Pelayanan Kesehatan yang ditanggung Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menagihkan langsung kepada Peserta berdasarkan informasi secara tertulis dari Pihak Pertama mengenai biaya yang tidak ditanggung oleh Pihak Pertama (Struk Discharge).
- (12) Dalam hal Peserta memperoleh Pelayanan Rawat Jalan menggunakan fasilitas JKN dari BPJS Kesehatan, Pihak Kedua wajib memastikan selisih koding INA-CBG yang dapat dibebankan ke Pihak Pertama adalah maksimum Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah). Apabila pada kunjungan peserta ada pemeriksaan penunjang dengan indikasi medis, maka Pihak Pertama akan menambahkan lagi Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- (13) Pihak Pertama tidak bertanggungjawab apabila Pihak Kedua tidak menagihkan kelebihan biaya yang tidak dijaminan kepada Peserta.
- (14) Pihak Kedua wajib memperhatikan informasi sehubungan dengan benefit dan/atau hak Pelayanan Kesehatan dari masing-masing Peserta.

b. Dalam hal Pihak Kedua tidak menggunakan Web Portal (manual):

- (1) Sebelum memperoleh Pelayanan Kesehatan di Faskes, Peserta wajib menunjukkan Persyaratan Administrasi sebagai berikut:
 - (i) Kartu Peserta;
 - (ii) Bukti identitas diri Peserta, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - (iii) Rujukan dari Sistem BPJS Kesehatan (jika Peserta menggunakan fasilitas JKN);
 - (iv) Surat Rujukan (jika Peserta tidak menggunakan fasilitas JKN); dan
 - (v) Dokumen lain yang mungkin diperlukan sebagaimana diberitahukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
- (2) Pihak Kedua wajib melakukan verifikasi atas Persyaratan Administrasi yang diberikan Peserta dengan menghubungi Tim Verifikator Pihak Pertama dan memastikan bahwa Peserta yang datang sesuai dengan Persyaratan Administrasi yang dibawa.
- (3) Apabila Peserta tidak dapat menunjukkan Persyaratan Administrasi (baik sebagian maupun keseluruhan) maka Pihak Kedua dapat menghubungi Tim Verifikator Pihak Pertama.
- (4) Atas permintaan verifikasi Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib memberikan rekonfirmasi selambat-lambatnya 2 (dua) jam sejak Pihak Kedua menghubungi Pihak Pertama, dan dalam keadaan darurat, sakit secara tiba-tiba, penyakit gawat, dan/atau kecelakaan, rekonfirmasi diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) jam sejak Pihak Kedua menghubungi Pihak Pertama.
- (5) Pihak Kedua wajib untuk mengisi secara detail dan lengkap Formulir Rawat Jalan yang sudah disediakan oleh Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
- (6) Struk Discharge hanya diterbitkan oleh Pihak Pertama pada Hari Kerja. Di luar Hari Kerja, dalam keadaan darurat, sakit secara tiba-tiba, penyakit gawat, dan/atau kecelakaan, maka Pihak Kedua wajib memperoleh konfirmasi Pihak Pertama secara lisan melalui telepon ke Tim Verifikator.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (7) Tindakan atau perawatan yang tidak memerlukan Pelayanan Rawat Inap, seperti operasi kecil dengan anestesi lokal tanpa penyulit, maka Pihak Kedua wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama sebelum memberikan tindakan atau perawatan tersebut kepada Peserta, berupa Surat Persetujuan Pembayaran.
- (8) Jika jatuh pada tanggal merah, hari libur nasional atau hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, maka Surat Persetujuan Pembayaran akan diberikan pada Hari Kerja berikutnya.
- (9) Pihak Pertama berhak untuk melakukan verifikasi atas setiap Peserta yang berkunjung ke Faskes, termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan proses administratif, permintaan pemeriksaan penunjang dan terapi obat yang diberikan kepada Peserta.
- (10) Pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi) yang disarankan oleh dokter dan/atau Tenaga Kesehatan Faskes wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama (dilengkapi dengan tanda tangan Verifikator Pihak Pertama) sebelum memberikan pemeriksaan tersebut kepada Peserta.
- (11) Pemberian obat pada Peserta rawat jalan adalah maksimum untuk 7 (tujuh) hari pemakaian, dan dalam kasus diagnosa kronis maksimum untuk 30 (tiga puluh) hari pemakaian.
- (12) Untuk pemberian:
 - (i) Obat dengan harga lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per tablet/kapsul/vial/flacon;
 - (ii) Tindakan medis yang akan dilakukan dengan biaya lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - (iii) Tindakan medis dan/atau bedah yang akan dilakukan kepada Peserta;
 - (iv) Pemeriksaan laboratorium dan/atau radiologi lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - (v) Obat-obatan di luar dari Formularium Pihak Pertama, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama sebelum diberikan kepada Peserta.
- (13) Apabila terjadi selisih biaya ataupun ditemukan informasi diagnosa yang merupakan pengecualian dari Pelayanan Kesehatan yang ditanggung Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib menagihkan langsung kepada Peserta berdasarkan informasi secara tertulis dari Pihak Pertama mengenai biaya yang tidak ditanggung oleh Pihak Pertama.
- (14) Dalam hal Peserta memperoleh Pelayanan Rawat Jalan menggunakan fasilitas JKN dari BPJS Kesehatan, Pihak Kedua wajib memastikan selisih koding INA-CBG yang dapat dibebankan ke Pihak Pertama adalah maksimum Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah). Apabila pada kunjungan peserta ada pemeriksaan penunjang dengan indikasi medis, maka Pihak Pertama akan menambahkan lagi Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- (15) Pihak Pertama tidak bertanggungjawab apabila Pihak Kedua tidak menagihkan kelebihan biaya yang tidak dijaminakan kepada Peserta.
- (16) Pihak Kedua wajib memperhatikan informasi sehubungan dengan benefit dan/atau hak Pelayanan Kesehatan dari masing-masing Peserta.

2. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap

a. Dalam hal Pihak Kedua menggunakan Web Portal

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (1) Sebelum memperoleh Pelayanan Kesehatan di Faskes, Peserta wajib menunjukkan Persyaratan Administrasi sebagai berikut:
 - (i) Kartu Peserta;
 - (ii) Bukti identitas diri Peserta, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - (iii) Rujukan dari Sistem BPJS Kesehatan (jika Peserta menggunakan fasilitas JKN);
 - (iv) Surat Rujukan (jika Peserta tidak menggunakan fasilitas JKN); dan
 - (v) Dokumen lain yang mungkin diperlukan sebagaimana diberitahukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
- (2) Pihak Kedua wajib melakukan verifikasi atas Persyaratan Administrasi dengan informasi yang tercantum dalam Web Portal dan memastikan bahwa calon pasien yang datang sesuai dengan Persyaratan Administrasi yang dibawa.
- (3) Pihak Pertama akan melakukan verifikasi melalui Web Portal, dalam hal Web Portal tidak berfungsi karena alasan apa pun, maka Pihak Kedua dapat menghubungi Tim Verifikator Pihak Pertama.
- (4) Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta harus memperhatikan hak Peserta sesuai yang tercantum dalam Web Portal.
- (5) Pihak Pertama berhak untuk melakukan verifikasi atas setiap Peserta yang berkunjung ke Faskes, termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan proses administratif, permintaan pemeriksaan penunjang dan terapi obat yang diberikan kepada Peserta.
- (6) Pihak Kedua wajib untuk mengisi secara detail dan Laporan Medis Awal yang sudah disediakan oleh Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
- (7) Pihak Kedua akan menghubungi Pihak Pertama dan mengirimkan surat keterangan masuk Rawat Inap, Formulir LMA yang disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi awal untuk diverifikasi Pihak Pertama dan Pihak Pertama wajib mengirimkan Surat Jaminan Awal melalui Web Portal selambat-lambatnya 2 (dua) jam sejak Pihak Kedua memperoleh verifikasi dari Web Portal.
- (8) Dalam hal menurut Pihak Pertama, diagnosa atas Peserta belum jelas, atau Pihak Pertama memerlukan informasi medis tambahan sehubungan dengan Peserta, maka penerbitan Surat Jaminan Awal dapat ditunda sampai dengan Pihak Pertama menganggap informasi dan keterangan tambahan sehubungan dengan Peserta sudah terpenuhi dan cukup.
- (9) Untuk pemberian:
 - (i) Obat dengan harga lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per tablet/kapsul/vial/flacon;
 - (ii) Tindakan medis yang akan dilakukan dengan biaya lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - (iii) Tindakan medis dan/atau bedah yang akan dilakukan kepada Peserta;
 - (iv) Pemeriksaan laboratorium dan/atau radiologi lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - (v) Obat-obatan di luar dari Formularium Pihak Pertama,
 wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama sebelum diberikan kepada Peserta.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (10) Peserta akan ditempatkan di kamar yang menjadi haknya sesuai Surat Jaminan Awal yang bersangkutan atau jawaban konfirmasi secara lisan yang diberikan oleh Pihak Pertama melalui Tim Verifikator Pihak Pertama.
- (11) Apabila kamar yang sesuai dengan Surat Jaminan Awal tidak tersedia atau penuh, maka:
- a) Pihak Kedua akan menganjurkan agar Peserta mengambil kelas kamar yang lebih rendah dari haknya; atau
 - b) Apabila Peserta memilih kelas kamar yang melebihi haknya, maka Pihak Kedua harus menagih selisih biaya kamar dan selisih biaya perawatan lainnya kepada Peserta pada saat keluar dari perawatan, kecuali ada pernyataan lain dalam Surat Jaminan Awal.
- (12) Pihak Pertama akan melakukan proses monitoring selama Peserta menjalankan perawatan. Pihak Kedua berkewajiban memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan terkait perawatan Peserta baik informasi medis maupun non medis.
- (13) Apabila Peserta telah diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawat Peserta di Faskes, maka Pihak Kedua wajib mengirimkan email kepada Pihak Pertama mengenai rincian biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan di Faskes, resume medis akhir, hasil pemeriksaan penunjang dan dokumen penunjang lainnya yang diminta Pihak Pertama, dan Pihak Pertama akan melakukan verifikasi terhadap biaya yang dikirimkan untuk menentukan apakah biaya Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh Peserta sudah sesuai dengan hak Peserta dan setelah itu Pihak Pertama akan mengirimkan Surat Persetujuan Pembayaran kepada Pihak Kedua. Dokumen tersebut dikirimkan ke Tim Verifikasi Pihak Pertama.
- (14) Pihak Pertama wajib mengirimkan Surat Jaminan Akhir/Surat Persetujuan Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) jam sejak Pihak Kedua menghubungi Pihak Pertama. dan mengirimkan persyaratan dokumen untuk penerbitan Surat Jaminan Akhir dengan lengkap dan benar
- (15) Biaya-biaya Pelayanan Kesehatan di luar yang tertera dalam Surat Persetujuan Pembayaran akan ditagihkan langsung oleh Pihak Kedua kepada Peserta.
- (16) Apabila terjadi selisih biaya, Pihak Kedua wajib menagihkan langsung kepada Peserta berdasarkan informasi secara tertulis dari Pihak Pertama mengenai biaya-biaya yang tidak ditanggung Pihak Pertama.
- (17) Pihak Pertama tidak bertanggungjawab apabila Pihak Kedua tidak menagihkan kelebihan biaya yang tidak dijaminakan kepada Peserta.
- (18) Pihak Kedua wajib memperhatikan informasi sehubungan dengan benefit dan/atau hak Pelayanan Kesehatan dari masing-masing Peserta.

b. Dalam hal Pihak Kedua tidak menggunakan Web Portal (manual):

- (1) Sebelum memperoleh Pelayanan Kesehatan di Faskes, Peserta wajib menunjukkan Persyaratan Administrasi sebagai berikut:
- (i) Kartu Peserta;
 - (ii) Bukti identitas diri Peserta, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - (iii) Rujukan dari Sistem BPJS Kesehatan (jika Peserta menggunakan fasilitas JKN);
 - (iv) Surat Rujukan (jika Peserta tidak menggunakan fasilitas JKN); dan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (v) Dokumen lain yang mungkin diperlukan sebagaimana diberitahukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
- (2) Pihak Kedua wajib melakukan verifikasi atas Persyaratan Administrasi yang diberikan Peserta dengan menghubungi Tim Verifikator Pihak Pertama dan memastikan bahwa calon pasien yang datang sesuai dengan Persyaratan Administrasi yang dibawa.
- (3) Apabila Peserta tidak dapat menunjukkan Persyaratan Administrasi (baik sebagian maupun keseluruhan) maka Pihak Kedua dapat menghubungi Tim Verifikator Pihak Pertama.
- (4) Atas permintaan verifikasi Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib memberikan rekonfirmasi selambat-lambatnya 2 (dua) jam sejak Pihak Kedua menghubungi Pihak Pertama, dan dalam keadaan darurat, sakit secara tiba-tiba, penyakit gawat, dan/atau kecelakaan, rekonfirmasi diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) jam sejak Pihak Kedua menghubungi Pihak Pertama.
- (5) Pihak Pertama berhak untuk melakukan verifikasi atas setiap Peserta yang berkunjung ke Faskes, termasuk namun tidak terbatas sehubungan dengan proses administratif, permintaan pemeriksaan penunjang dan terapi obat yang diberikan kepada Peserta.
- (6) Pihak Kedua wajib untuk mengisi secara detail dan lengkap Formulir Rawat Jalan yang sudah disediakan oleh Pihak Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini.
- (7) Pihak Kedua akan menghubungi Pihak Pertama dan mengirimkan surat keterangan masuk Rawat Inap, Formulir LMA yang disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi awal untuk diverifikasi Pihak Pertama dan Pihak Pertama wajib mengirimkan Surat Jaminan Awal selambat-lambatnya 2 (dua) jam sejak Pihak Kedua menghubungi Pihak Pertama.
- (8) Dalam hal menurut Pihak Pertama, diagnosa atas Peserta belum jelas, atau Pihak Pertama memerlukan informasi medis tambahan sehubungan dengan Peserta, maka penerbitan Surat Jaminan Awal dapat ditunda sampai dengan Pihak Pertama menganggap informasi dan keterangan tambahan sehubungan dengan Peserta sudah terpenuhi dan cukup.
- (9) Untuk pemberian:
 - (i) Obat dengan harga lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per tablet/kapsul/vial/flacon;
 - (ii) Tindakan medis yang akan dilakukan dengan biaya lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - (iii) Tindakan medis dan/atau bedah yang akan dilakukan kepada Peserta;
 - (iv) Pemeriksaan laboratorium dan/atau radiologi lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - (v) Obat-obatan di luar dari Formularium Pihak Pertama, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama sebelum diberikan kepada Peserta.
- (10) Peserta akan ditempatkan di kamar yang menjadi haknya sesuai Surat Jaminan Awal yang bersangkutan atau jawaban konfirmasi secara lisan yang diberikan oleh Pihak Pertama melalui Tim Verifikator Pihak Pertama.
- (11) Apabila kamar yang sesuai dengan Surat Jaminan Awal tidak tersedia atau penuh, maka:

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- a) Pihak Kedua akan menganjurkan agar Peserta mengambil kelas kamar yang lebih rendah dari haknya; atau
 - b) Apabila Peserta memilih kelas kamar yang melebihi haknya, maka Pihak Kedua harus menagih selisih biaya kamar dan selisih biaya perawatan lainnya kepada Peserta pada saat keluar dari perawatan, kecuali ada pernyataan lain dalam Surat Jaminan Awal.
- (12) Pihak Pertama akan melakukan proses monitoring selama Peserta menjalankan perawatan. Pihak Kedua berkewajiban memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan terkait perawatan Peserta baik informasi medis maupun non medis.
- (13) Apabila Peserta telah diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawat Peserta di Faskes, maka Pihak Kedua wajib mengirimkan email kepada Pihak Pertama mengenai rincian biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan di Faskes, resume medis akhir, hasil pemeriksaan penunjang dan dokumen penunjang lainnya yang diminta Pihak Pertama, dan Pihak Pertama akan melakukan verifikasi terhadap biaya yang dikirimkan untuk menentukan apakah biaya Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh Peserta sudah sesuai dengan hak Peserta dan setelah itu Pihak Pertama akan mengirimkan Surat Persetujuan Pembayaran kepada Pihak Kedua. Dokumen tersebut dikirimkan ke Tim Verifikasi Pihak Pertama.
- (14) Pihak Pertama wajib mengirimkan Surat Jaminan Akhir/Surat Persetujuan Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) jam sejak Pihak Kedua menghubungi Pihak Pertama. dan mengirimkan persyaratan dokumen untuk penerbitan Surat Jaminan Akhir dengan lengkap dan benar.
- (15) Biaya-biaya Pelayanan Kesehatan di luar yang tertera dalam Surat Persetujuan Pembayaran akan ditagihkan langsung oleh Pihak Kedua kepada Peserta.
- (16) Apabila terjadi selisih biaya, Pihak Kedua wajib menagihkan langsung kepada Peserta berdasarkan informasi secara tertulis dari Pihak Pertama mengenai biaya-biaya yang tidak ditanggung Pihak Pertama.
- (17) Pihak Pertama tidak bertanggungjawab apabila Pihak Kedua tidak menagihkan kelebihan biaya yang tidak dijaminakan kepada Peserta.
- (18) Pihak Kedua wajib memperhatikan informasi sehubungan dengan benefit dan/atau hak Pelayanan Kesehatan dari masing-masing Peserta.

3. Pelayanan Kesehatan Lainnya

Mekanisme pelaksanaan Pelayanan Kesehatan selain Pelayanan Rawat Jalan dan Pelayanan Rawat Inap akan diberitahukan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan masing-masing Peserta.

4. Penolakan Peserta

Pihak Kedua harus memperlakukan pasien sebagai pasien umum (bukan sebagai Peserta yang ditanggung Pihak Pertama) apabila:

- a. Data Peserta tidak sesuai dan/atau Peserta tidak berhak atas suatu Pelayanan Kesehatan dan/atau manfaat, sebagaimana tercantum di dalam Web Portal atau sebagaimana diberitahukan oleh Tim Verifikator Pihak Pertama kepada Pihak Kedua; atau
- b. Peserta tidak dapat memberikan Persyaratan Administrasi yang diperlukan untuk memperoleh pertanggungan Pihak Pertama; atau

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- c. Persyaratan Administrasi milik Peserta palsu, tidak sah, tidak valid, tidak berlaku dan/atau tidak sesuai dengan Peserta.

5. Pengecualian

Di bawah ini merupakan pengecualian secara umum, dalam pelaksanaannya pengecualian telah diatur secara sistematis berdasarkan kode diagnosa ICD 10 sesuai dengan ketentuan masing-masing Peserta.

- i. Perawatan atau pengobatan yang tidak dibutuhkan secara medis atau tidak sesuai dengan perintah dokter yang merawat atau sampai suatu tingkatan di mana hal itu dapat dibayar oleh setiap asuransi lain atau dapat diberikan ganti rugi kepada Peserta (*double claim*) termasuk namun tidak terbatas pada Pelayanan Kesehatan yang sudah ditanggung dan dibayar oleh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja atau program pemerintah atau swasta lainnya;
- ii. Bedah kosmetik, perawatan kosmetik, alat perbaikan fungsi tubuh lainnya, segala jenis sabun dan segala jenis sampo;
- iii. Cedera atau penyakit yang timbul sebagai akibat dari pemakaian alkohol yang berlebihan, narkotika dan obat-obat bius atau sejenisnya;
- iv. Tindakan-tindakan yang berhubungan dengan atau sebagai akibat dari aborsi yang bukan atas alasan medis, sterilisasi, kontrasepsi dan pengobatan sehubungan fertilitas;
- v. Kecelakaan lalu lintas di mana peserta sebagai pengendara tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku;
- vi. Pengobatan yang berhubungan dengan penyakit kelamin dan atau penyakit menular seksual serta akibat yang ditimbulkannya, HIV, AIDS dan ARC (*AIDS Related Complex*);
- vii. Segala jenis vitamin dan suplemen yang bukan untuk penyembuhan dan dalam jumlah yang tidak wajar;
- viii. Bunuh diri, usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan diri sendiri;
- ix. Perang atau segala tindakan peperangan, dinyatakan atau tidak, kegiatan-kegiatan melawan hukum atau terorisme, dinas aktif dalam angkatan bersenjata mana pun, partisipasi langsung dalam demonstrasi, huru-hara, pemberontakan atau keributan sipil;
- x. Layanan/prosedur medis atau bedah yang bersifat percobaan atau belum diakui sebagai pengobatan medis standar dan secara meluas oleh bidang kedokteran modern sebagai hal yang tepat untuk mengobati suatu penyakit misalnya *ozone therapy*, *chelation therapy*, *iridology*, *cell implant therapy*, *laser therapy* untuk koreksi refraksi, berbagai bentuk penyinaran lain untuk kosmetika atau estetika, dan/atau obat yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada pengobatan tradisional, pengobatan alternatif, pengobatan yang hanya bersifat suportif, *food supplements*, perawatan hiperbarik, akupunktur (kecuali dilakukan oleh dokter, hanya biaya dokter yang diganti) pengobatan chiropraktik dan pengobatan naturopatik, serta perlengkapan yang semata-mata untuk kenyamanan Peserta;
- xi. Bencana alam, luka-luka atau penyakit yang mengakibatkan timbulnya penyakit epidemi termasuk penyakit epidemi akibat perang/peperangan yang telah dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau lembaga pemerintahan sah lainnya di Republik Indonesia.
- xii. Penyakit atau cedera yang timbul akibat dari Peserta mempersiapkan diri untuk mengambil bagian atau berpartisipasi dalam perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya

Pihak Pertama	Pihak Kedua

dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, mendaki gunung, *scuba diving*, olah raga bela diri dan setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Perjalanan dengan pesawat terbang atau semacamnya kecuali Pasien merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang tetap

- xiii. Pemeriksaan Penunjang terkait diagnosa kasus suspek wabah nasional.

6. Kecurangan

Pihak Pertama berhak untuk tidak memproses penagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang dikirimkan oleh Pihak Kedua dan/atau menerbitkan surat peringatan dan/atau mengakhiri Perjanjian ini dalam hal Pihak Kedua melakukan kecurangan sebagai berikut:

- Memberikan, mengungkapkan, dan/atau membuat pernyataan dan/atau informasi yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peserta dan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada klaim/tagihan yang dapat menimbulkan kerugian;
- Memberikan Pelayanan Kesehatan yang berlebihan kepada Peserta yang secara medis tidak diperlukan, atau tidak sesuai/konsisten dengan diagnosa baik atas permintaan dari dan/atau dengan bekerja sama dengan Peserta maupun pihak lain;
- Menggandakan atau dengan cara apa pun membuat biaya Pelayanan Kesehatan ditagihkan ke lebih dari 1 (satu) pihak penjamin/penanggung yang menyebabkan tagihan fiktif.

7. Pelindungan Data Pribadi

Masing-masing Pihak berkewajiban untuk memastikan bahwa para karyawan, Tenaga Kesehatan, petugas, perwakilan, mitra, dan/atau kontraktornya:

- Memproses Data Pribadi (sebagai didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelindungan Data Pribadi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hanya memproses Data Pribadi apabila dan hanya sejauh diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini;
- Pengungkapan Data Pribadi harus mematuhi ketentuan Pasal 8 Perjanjian ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa karyawan dan perwakilannya yang memproses Data Pribadi memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan hal tersebut dan tetap patuh pada kewajiban kerahasiaan dan pelindungan Data Pribadi dalam Perjanjian ini;
- Masing-masing Pihak harus melaksanakan dan mempertahankan tindakan atau langkah administratif, teknis, dan organisasi yang cukup untuk menjaga keamanan Data Pribadi dan mencegah penghapusan, perubahan, akses, penyalinan, dan/atau penggunaan yang tidak sah atas Data Pribadi, serta pencurian, pemalsuan, kehilangan, dan/atau kesalahan teknis sehubungan dengan Data Pribadi.

8. Syarat dan Ketentuan Web Portal

Sehubungan dengan penggunaan Web Portal oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa:

- Pihak Kedua akan menggunakan Web Portal sesuai dengan peruntukannya dan hanya untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini, dan dalam menggunakan Web Portal, Pihak Kedua

Pihak Pertama	Pihak Kedua

menyatakan dan menjamin akan mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama sehubungan dengan penggunaan Web Portal, dan tidak akan menggunakan Web Portal untuk hal-hal ilegal dan melanggar peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi, kesehatan, rekam medis, dan perlindungan data pribadi.

- b. Pihak Kedua mengetahui dan mengerti bahwa Web Portal dan seluruh data, logo, simbol, isi dan konten ("Materi") adalah milik Pihak Pertama, dan Pihak Kedua tidak akan menyalahgunakan Web Portal untuk kepentingan pihak mana pun dan untuk tujuan apa pun.
- c. Baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari pihak (baik Peserta, karyawan maupun pihak lain) yang data pribadi maupun rekam medisnya akan dikumpulkan, diproses maupun digunakan dalam Web Portal, dan Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa seluruh informasi rahasia, rekam medis dan data pribadi baik milik Para Pihak maupun pihak lainnya akan dikumpulkan, diproses, diolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi dan rekam medis.
- d. Dalam penggunaan Web Portal untuk tujuan Perjanjian ini, Pihak Kedua akan diberikan akses ke Web Portal, oleh karena itu Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan kredensial akses yang diberikan kepadanya, serta menjaganya agar tetap aman dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaan tidak sah atas akses dan/atau kredensialnya.
- e. Web Portal disediakan "sebagaimana adanya" dalam arti Pihak Kedua mengakui dan menyetujui bahwa seluruh risiko yang ditimbulkan dari penggunaan fitur Web Portal oleh Pihak Kedua tetap sepenuhnya ada pada Pihak Kedua.
- f. Pihak Kedua dilarang melakukan hal-hal berikut ini kepada Web Portal:
 - (i) Melisensikan mensublisensikan, menjual, mentransfer, mengalihkan, mendistribusikan atau mengeksploitasi secara komersial atau membuat Web Portal menjadi tersedia untuk pihak ketiga dengan cara apa pun;
 - (ii) memodifikasi atau membuat karya turunan berdasarkan Web Portal;
 - (iii) "Mencerminkan" Web Portal pada server atau perangkat berbasis nirkabel atau internet lainnya;
 - (iv) membongkar, mendekompilasi, merekayasa balik, memecahkan atau berusaha untuk mendapatkan dan membuat kode atau mengekstraksi perangkat lunak dari Web Portal atau perangkat lunak atau layanan apa pun yang disediakan pada atau melalui Web Portal;
 - (v) menggunakan program atau skrip manual atau otomatis apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada *web spiders*, *web crawlers*, *web robots*, *web ants*, *web indexers*, bot, virus atau *worm*, atau program apa pun yang dapat membuat beberapa permintaan server per detik, (a) untuk terlalu membebani atau menghambat operasi dan/atau kinerja Web Portal; (b) untuk melakukan kegiatan penggalian atau pengikisan data, atau (c) dengan cara apa pun mereproduksi atau menghindari struktur navigasi atau penyajian Web Portal atau kontennya;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

- (vi) memposting, mendistribusikan, atau mereproduksi dengan cara apa pun materi yang dilindungi hak cipta, merek dagang, atau informasi hak kepemilikan lainnya tanpa mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pemilik hak kepemilikan tersebut;
 - (vii) menghapus segala pemberitahuan hak cipta, merek dagang, atau hak kepemilikan lainnya yang terdapat pada Web Portal;
 - (viii) menggunakan Web Portal untuk: (a) mengirim sampah internet (spam) atau pesan duplikat atau yang tidak diminta; (b) mengirim atau menyimpan materi yang melanggar, cabul, mengancam, memfitnah, atau materi yang melanggar hukum atau penyiksaan, termasuk namun tidak terbatas pada materi yang berbahaya bagi anak-anak atau melanggar hak privasi pihak ketiga; (c) mengirim materi yang mengandung virus, *worm*, *trojan horse* atau kode komputer, file, skrip, agen atau program berbahaya lainnya; (d) mengganggu atau mengacaukan integritas atau kinerja Web Portal atau data yang terkandung di dalamnya; (e) berupaya mendapatkan akses tidak sah ke Web Portal atau perangkat lunak, sistem, atau jaringan terkait; (f) menyamar sebagai orang atau entitas apa pun atau memalsukan hubungannya dengan seseorang atau suatu entitas; atau (vii) terlibat dalam perilaku apa pun yang dapat merusak reputasi Pihak Pertama;
 - (ix) mengakses dan/atau menggunakan akses ke Web Portal setelah jangka waktu Perjanjian ini berakhir,
- (selanjutnya disebut sebagai “**Penyalahgunaan**”).
- g. Pihak Pertama berhak menangguhkan dan/atau mengakhiri Perjanjian ini apabila Pihak Kedua diduga kuat adanya Penyalahgunaan dan/atau pelanggaran terhadap Syarat dan ketentuan Web Portal.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

LAMPIRAN 4 - BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

1. Biaya Pelayanan Kesehatan

- a. Atas tagihan biaya Pelayanan Kesehatan, Pihak Kedua akan memberikan suatu biaya rujukan atau *referral fee* sebesar: 0(mohon isi)% (nol persen) dari total tagihan biaya Pelayanan Kesehatan yang dikirimkan Pihak Kedua ke Pihak Pertama (“**Referral Fee**”). Referral Fee akan diberikan secara terpisah dengan tata cara sebagaimana diatur dalam poin 3 dalam Lampiran ini.
- b. Pihak Kedua akan memberikan top up kamar sebanyak 1 (satu) tingkat dari hak Peserta.
- c. Para Pihak bertanggung jawab atas kewajiban pajaknya masing-masing sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.
- d. Dalam hal Peserta mendapatkan Pelayanan Kesehatan berupa Pelayanan Rawat Inap dengan menggunakan fasilitas JKN dari BPJS Kesehatan, maka Pihak Kedua wajib memaksimalkan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta sesuai koding INA-CBG dan memastikan selisih biaya yang timbul yang menjadi beban Pihak Pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut:

Hak rawat Kelas II (dua) naik ke Kelas I (satu).	Selisih tarif INA-CBG pada kelas rawat inap Kelas I (satu) dengan tarif INA-CBG pada kelas rawat inap Kelas II (dua).
Hak rawat kelas I (satu) naik ke Kelas di atas Kelas I (satu).	Selisih tarif INA-CBG Kelas I (satu) dengan tarif kelas di atas kelas I (satu) yaitu paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif INA-CBG Kelas I (satu).
Hak rawat Kelas II (dua) naik ke Kelas di atas Kelas I (satu).	Selisi tarif INA-CBG antara Kelas I (satu) dengan Kelas II (dua) ditambah paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif INA-CBG Kelas I (satu).
Peserta dengan hak kelas III (tiga) tidak diperkenankan untuk naik kelas rawat inap. Apabila Peserta menginginkan kenaikan kelas, maka penjaminan oleh BPJS Kesehatan miliknya akan gugur.	

- e. Biaya yang terjadi menurut ketentuan poin d di atas (selisih dari tarif INA-CBG) menjadi tanggung jawab Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- f. Dalam hal Peserta menggunakan fasilitas JKN dari BPJS Kesehatan: Tagihan yang dikirim oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah berdasarkan total tagihan dari setiap Pelayanan Kesehatan yang diterima oleh Peserta sesuai indikasi medis, dikurangi tarif INA-CBG, sesuai ketentuan poin d di atas, kecuali dinyatakan berbeda oleh Pihak Pertama.

2. Penagihan Biaya Pelayanan Kesehatan

- a. Pihak Kedua wajib melengkapi dokumen yang diperlukan yang berkaitan dengan semua Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta untuk kepentingan penagihan dan administrasi (selanjutnya disebut sebagai “**Dokumen Penagihan**”), yaitu:

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Commented [F3]: Cc keuangan

Commented [F4]: Cc keuangan

Formatted: Highlight

- (i) Salinan bukti identitas diri Peserta dan Kartu Peserta;
 - (ii) Salinan surat rujukan/surat pengantar berobat (jika ada)
 - (iii) Salinan Surat Jaminan Awal;
 - (iv) Salinan Struk Discharge dan/atau Surat Persetujuan Pembayaran;
 - (v) Resume medis Peserta;
 - (vi) Salinan Formulir Rawat Jalan (jika ada);
 - (vii) Salinan hasil seluruh pemeriksaan penunjang yang dilakukan;
 - (viii) Rincian tagihan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Rekapen penagihan memakai penomoran;
 - (b) Tanggal berobat dilembar penagihan harus sama dengan tanggal di rekapen rincian tagihan;
 - (c) Nominal tagihan harus sama dengan nominal di rekapen rincian tagihan dan Surat Persetujuan Pembayaran;
 - (ix) Kuitansi pembayaran memakai meterai dan stempel basah Faskes.
- b. Dokumen Penagihan dikirimkan kepada Pihak Pertama dengan ditujukan kepada:
- PT ASURANSI JIWA TEGUH PELITA PELINDUNG**
Ruko Jl. Duyung No. 100 F, Kelurahan Tangkerang Barat,
Kecamatan Marpojan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28124
UP : Verifikator Pengembangan Layanan
- c. Pembayaran tagihan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Dokumen Penagihan diterima lengkap dan benar, dengan cara mentransfer langsung ke nomor rekening Pihak Kedua sebagai berikut:
- € RS Prima Husada Malang
- Atas nama : PT Disa Prima Medika (mohon isi!)
- Bank : PT Bank Central Asia Tbk (mohon isi!)
- Cabang : Malang - Singosari (mohon isi!)
- No. Rekening : 368 3040700 (mohon isi!)
- Kode SWIFT/BAN : CENAIDJA
- RS Prima Husada Sukorejo
- Atas nama : PT Disa Prima Medika
- Bank : Bank MAndiri
- Cabang : Malang - Soetoyo
- No. Rekening : 144 00555 33324
- d. Dalam hal terdapat Dokumen Penagihan yang belum lengkap dan/atau masih terdapat informasi lainnya yang harus dilengkapi oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan menghubungi Pihak Kedua, dan Pihak Kedua wajib melengkapi Dokumen Penagihan dan/atau informasi yang diminta oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan melakukan pembayaran sesuai ketentuan pada huruf C angka romawi ini.
- e. Pihak Kedua wajib melengkapi kekurangan Dokumen Penagihan dan/atau informasi yang diminta oleh Pihak Pertama sebagaimana tersebut di atas selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan kekurangan Dokumen Penagihan dan/atau informasi.
- f. Dalam hal Pihak Kedua tidak melengkapi kekurangan Dokumen Penagihan dan/atau informasi dalam 7 (tujuh) Hari Kerja, maka Pihak Pertama berhak untuk mengembalikan Dokumen

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Formatted: Font: Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 1,25 cm, No bullets or numbering

Penagihan yang belum lengkap tersebut. Pihak Kedua dapat mengirimkan kembali Dokumen Penagihan yang telah dilengkapi selama belum melewati batas waktu masa kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam huruf h angka romawi di bawah ini.

- g. Apabila terdapat perubahan rekening pembayaran sebagaimana disebutkan dalam huruf C angka romawi ini, maka hal tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- h. Para Pihak sepakat, bahwa Dokumen Penagihan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tidak boleh melebihi batas waktu masa kadaluwarsa 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Peserta selesai menjalani perawatan di Faskes. Apabila Dokumen Penagihan yang diterima Pihak Pertama beserta seluruh kelengkapan tagihan lainnya melebihi batas waktu yang ditentukan maka Pihak Pertama berhak untuk tidak melakukan pembayaran atas Dokumen Penagihan tersebut.

3. Penagihan Referral Fee atas Biaya Pelayanan Kesehatan

- a. Penagihan Referral Fee dapat dilakukan oleh Pihak Pertama pada setiap bulannya sesuai biaya Pelayanan Kesehatan yang sudah dibayarkan, dengan mengirimkan dokumen penagihan sebagai berikut:
 - (i) Tagihan/invoice;
 - (ii) Kuitansi;
 - (iii) Faktur pajak,
 ("Dokumen Penagihan Referral Fee").

- b. Dokumen Penagihan Referral Fee dikirimkan kepada Pihak Kedua dengan ditujukan kepada:

(nama badan hukum/Faskes) RS Prima Husada Malang

Alamat : Banjjararum Selatan No 3-7 Mondoroko, Kec.Singosari, Kab.Malang, Jawa Timur (mohon isi)

U.p. : Lilik Kurniati (mohon isi)

No. Telepon : 0813 3142 9720 (mohon isi)

Email : admklaim.rsph@gmail.com (mohon isi)

RS Prima Husada Sukorejo

Alamat : Jl.Surabya – Malang Km 54 Lemahbang, Kec.Sukorejo, Kab.Pasuruan, Jawa Timur

U.p. : Anita Sari, S.E

No. Telepon : (0343) 6745000

Email : keuangan@sukorejo.rs-primahusada.com

- c. Pembayaran tagihan Referral Fee akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Dokumen Penagihan Referral Fee diterima oleh Pihak Kedua, dengan cara mentransfer langsung ke nomor rekening Pihak Pertama sebagai berikut:

Atas nama : [UNTUK DIISI KEMUDIAN]

Bank : Bank Sinarmas

Cabang : [UNTUK DIISI KEMUDIAN]

No. Rekening : [UNTUK DIISI KEMUDIAN]

- d. Dalam hal terdapat Dokumen Penagihan Referral Fee yang belum lengkap dan/atau masih terdapat informasi lainnya yang harus dilengkapi oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Formatted: Font: Bold

menghubungi Pihak Pertama paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah Dokumen Penagihan Referral Fee diterima Pihak Kedua, dan Pihak Pertama wajib melengkapi Dokumen Penagihan Referral Fee dan/atau informasi yang diminta oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua akan melakukan pembayaran sesuai ketentuan pada poin (c) di atas. Apabila sampai dengan lewatnya 7 (tujuh) Hari Kalender setelah Dokumen Penagihan Referral Fee diterima Pihak Kedua, tidak ada pemberitahuan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk melengkapi Dokumen Penagihan Referral Fee, maka Dokumen Penagihan Referral Fee dianggap sudah lengkap dan benar.

- e. Bahwa atas Penagihan Referral Fee tersebut akan dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan tarif PPN yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia dengan menerbitkan faktur pajak kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pada saat melakukan pembayaran Referral Fee kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua akan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa perantara dengan tarif sebesar 2% (dua persen). Pihak Kedua wajib menyediakan bukti pemotongan pajak yang sah atau bukti lain yang sesuai yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak yang berwenang kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak PPh Pasal 23 tersebut dipotong dan dibayarkan oleh Pihak Kedua ke Otoritas Perpajakan yang berwenang.
- g. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia berkaitan dengan perpajakan, maka Para Pihak sepakat untuk mengikuti perubahan ketentuan hukum tersebut.

Pihak Pertama	Pihak Kedua